CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Fiche IV - B - 5

Version 1.5.0

Du 01/09/2026

CONDUITE À TENIR

Rédacteurs :
Daniel MEYRAN
Julien PAPOZ
Olivier BALAN
Denis LARGER

Perte de connaissance

DÉFINITION

Une perte de connaissance est une perte de contact de la victime, temporaire ou permanente, se manifestant par une incapacité à réagir avec d'autres personnes et son environnement.

CAUSES

Les causes des pertes de connaissance sont :

- traumatiques (choc, noyade, accident électrique) ;
- médicales ;
- toxiques.

CONSÉQUENCES

Une personne qui a perdu connaissance et qui est laissée sur le dos est exposée à des difficultés respiratoires du fait :

- d'une diminution de son tonus musculaire qui peut entraîner une obstruction des voies aériennes par la chute de la langue et de l'épiglotte en arrière et empêcher toute respiration naturelle ou artificielle (fig 1).
- d'une perte des réflexes de déglutition qui provoquent un encombrement des voies aériennes par l'écoulement de salive, de sang ou de liquide gastrique dans les voies respiratoires et les poumons.

Une perte de connaissance peut évoluer vers un arrêt respiratoire puis vers un arrêt cardiaque. En effet, la respiration n'est possible que si les voies aériennes permettent le passage de l'air sans encombre.

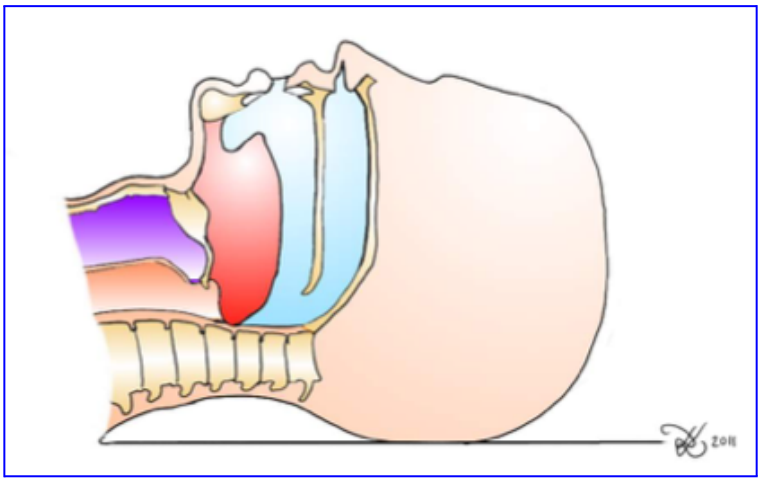


Figure 1 : *obstruction des voies aériennes par la langue*

BILAN

Lors de bilan d'urgence vitale (fiche III-C), le secouriste constate que :

- la **victime ne répond pas** et **ne réagit à aucune sollicitation verbale ou physique** (elle n'obéit pas aux ordres simples), elle a perdu connaissance ;
- la **ventilation** est présente et normale après retournement de la victime sur le dos (Fiche V-G-1) et libération des voies aériennes (Fiches V-C-8 à V-C-10).

PRINCIPES DE L'ACTION

- Maintenir les voies aériennes de la victime libres pour lui permettre de respirer ;
- Limiter toute aggravation d'une lésion du rachis si la victime présente un traumatisme.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Matériel de premiers secours : lots A, B, ou C ;
- Sac d'administration d'oxygène ;
- Aspirateur de mucosités ;
- Collier cervical (si nécessaire).

CONDUITE À TENIR

La victime a perdu connaissance, ventile normalement a la suite d'un événement non traumatique

- Placer la victime en **position latérale de sécurité** (PLS) pour maintenir la liberté des voies aériennes (Fiche V-D-1) (fig. 2).
  Le retournement sur le côté gauche de la femme enceinte, ou d'une victime obèse, permet d'éviter l'apparition d'une détresse par compression de certains vaisseaux sanguins de l'abdomen



Figure 2 : position latérale de sécurité à la suite d'un événement non traumatique

La victime a perdu connaissance, ventile normalement à la suite d'un traumatisme ou d'un événement d'origine inconnue

Dans l'attente d'un avis médical:

- laisser la victime sur le dos ;
- poursuivre la stabilisation de la tête de la victime (Fiche V-F-1) ;
- assurer une liberté des voies aériennes permanente (Fiche V-C-9).

Après avis médical, respecter les consignes, c'est à dire :

- laisser la victime sur le dos ou ;
- placer la victime en PLS à 2 secouristes (Fiche V-D-2) à la demande du médecin ou lors de la survenue de régurgitations ou de vomissements. Une palpation sommaire à la recherche de lésions traumatiques permet de définir au préalable le côté de retournement lors de la PLS.

Dans tous les cas

- si nécessaire :
  - administrer de l'oxygène en inhalation ;
  - réaliser une aspiration des sécrétions en présence de signes d'encombrements ;
- Protéger la victime contre le froid, la chaleur ou les intempéries.
- Poursuivre le bilan et surveiller particulièrement
  - la conscience de la victime ;
  - la respiration.

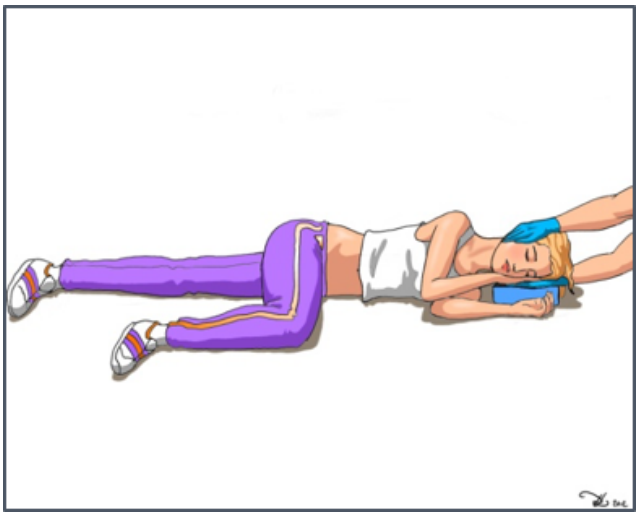


Figure 3 : position latérale de sécurité sur indication médicale à la suite d'un traumatisme ou d'un événement d'origine inconnue

La victime a perdu connaissance et ventile normalement, le secouriste est seul et sans matériel (hors situation à nombreuses victimes)

Lorsque la victime a perdu connaissance et respire, et que le secouriste se retrouve seul et sans matériel, il convient pour ce dernier d'appliquer la conduite à tenir suivante :

A la suite d'un évènement non traumatique

- la placer en position stable sur le côté, en position latérale de sécurité (PLS) ;
- faire alerter ou alerter les secours, respecter leurs consignes ;
- surveiller en permanence la respiration de la victime, jusqu'à l'arrivée des secours. Pour cela :
    - regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent ;
    - écouter d'éventuels sons provoqués par la respiration ;
    - sentir, avec la main, les mouvements du ventre et de la poitrine.

A la suite d'un traumatisme ou d'un événement d'origine inconnue

- laisser la victime sur le dos ;
- faire alerter ou alerter les secours, respecter leurs consignes ;
- surveiller en permanence la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours comme effectué lors de la recherche de la respiration ;
- si la victime vomit ou régurgite, la mettre sur le côté en maintenant si possible l'axe tête-cou-tronc, en demandant de l'aide le cas échéant.

Dans tous les cas

- compléter le bilan ;
- protéger contre la chaleur, le froid ou les intempéries ;
- si la respiration de la victime s'arrête ou devient anormale, il convient d'adopter la conduite à tenir face à un arrêt cardiaque et de prévenir les secours de l'évolution.